



Gestão das Finanças Públicas para a Saúde

Conceitos Chave

Objectivo. Esta nota técnica é um instrumento de trabalho desenvolvido para apoiar a Avaliação da Gestão das Finanças Públicas no Sector da Saúde de Angola, realizada com o apoio técnico da Organização Mundial da Saúde (OMS) Angola e com recurso ao FinHealth Toolkit 2.0, desenvolvido conjuntamente pela OMS e pelo Banco Mundial. A nota estabelece definições de referência para três conceitos centrais da avaliação — Gestão das Finanças Públicas (GFP), Risco Fiduciário (RF) e Espaço Fiscal (EF) — e explicita a sua aplicação específica ao Sector da Saúde.

Âmbito. As definições combinam a abordagem do FinHealth 2.0 e dos materiais técnicos utilizados na avaliação com referências institucionais reconhecidas, incluindo FMI, Banco Mundial, OMS e PEFA. A nota distingue os conceitos entre si e clarifica a sua relação com o financiamento da saúde, a execução orçamental e a prestação de serviços.

Como Utilizar. A nota deve ser utilizada como referência comum nas formações, entrevistas, sessões técnicas e discussões da avaliação, em particular quando se analisem o funcionamento dos sistemas de GFP, os riscos associados à utilização dos recursos públicos e a possibilidade de criar ou preservar recursos públicos sustentáveis para a saúde.

Distinções Essenciais. GFP, risco fiduciário e espaço fiscal são conceitos relacionados, mas não equivalentes. A GFP descreve como os recursos públicos são planeados, orçamentados, executados, controlados, contabilizados, reportados e fiscalizados. O risco fiduciário considera a possibilidade de esses recursos não serem utilizados com economia e eficiência para os fins previstos. O espaço fiscal considera a margem para decisões fiscais adicionais sem comprometer a sustentabilidade fiscal. No Sector da Saúde, a qualidade da GFP condiciona a capacidade de transformar espaço fiscal e dotações orçamentais em recursos efectivamente disponíveis para a prestação de serviços.

Sobre Este Documento. Documento interno de trabalho preparado como instrumento de apoio à avaliação e ao desenvolvimento de capacidades. Não constitui uma tradução oficial das metodologias ou publicações internacionais citadas, nem substitui a legislação, regulamentação, classificadores, manuais ou outros instrumentos oficiais aplicáveis em Angola. Sempre que a interpretação de um conceito afecte a aplicação da metodologia, prevalecem o FinHealth Toolkit 2.0 e os documentos de referência originais.

1. Gestão das Finanças Públicas (GFP)

Definição geral. A GFP corresponde ao conjunto de leis, instituições, políticas, sistemas, processos e práticas através dos quais o Governo planeia, mobiliza, afecta, executa, controla, contabiliza, reporta e fiscaliza os recursos públicos, incluindo os activos e os passivos. Abrangem o ciclo orçamental e funções conexas, designadamente: planeamento fiscal e orçamental; preparação e aprovação do orçamento; execução; gestão de tesouraria e de caixa; contratação pública; controlo interno; contabilidade e reporte financeiro; auditoria e fiscalização externa. Uma GFP eficaz deve contribuir para três resultados centrais: disciplina fiscal agregada, alocação estratégica de recursos e prestação eficiente de serviços públicos.^{1 2}

Aplicação ao Sector da Saúde. No Sector da Saúde, a GFP corresponde à aplicação das regras, instituições e processos gerais do Governo, bem como dos arranjos sectoriais relevantes, aos recursos públicos destinados à saúde. O FinHealth 2.0 coloca a prestação de serviços no centro da análise: procura identificar de que modo as regras e práticas de GFP afectam a disponibilidade, a previsibilidade, a flexibilidade e a utilização dos recursos necessários para pessoal, medicamentos, bens e serviços, equipamento, infraestruturas e o funcionamento das unidades sanitárias. Assim, a análise da GFP na saúde não se limita à conformidade financeira; examina se o sistema permite converter prioridades e dotações orçamentais em recursos utilizáveis e, em última instância, em serviços de saúde.^{3 4}

Distinção importante. GFP não é sinónimo de política fiscal ou de financiamento da saúde. A política fiscal determina, entre outros aspectos, receitas, despesas agregadas, défice, financiamento e dívida. O financiamento da saúde abrange as funções de mobilização de receitas, agregação de fundos e compra de serviços. A GFP fornece as regras e os processos públicos por meio dos quais muitas dessas decisões são orçamentadas, executadas, controladas e reportadas.

2. Risco Fiduciário (RF)

Definição geral. O risco fiduciário é o risco de os recursos não serem utilizados de forma económica e eficiente para os fins previstos. Na prática, inclui o risco de os recursos serem utilizados de forma não autorizada ou inadequada, não alcançarem valor adequado, ou não poderem ser devidamente controlados, contabilizados e reportados. Pode resultar de fraude, corrupção, erro, desperdício, má gestão, fraca capacidade institucional ou fragilidades nos sistemas de orçamento, de fluxo de fundos, de controlo interno, de contratação pública, de contabilidade, de reporte e de auditoria.⁵

Aplicação ao Sector da Saúde. No Sector da Saúde, o risco fiduciário refere-se à possibilidade de os recursos destinados às prioridades, programas e serviços de saúde não chegarem às entidades, unidades, factores de produção ou beneficiários previstos; serem utilizados para fins diferentes dos autorizados; não produzirem valor adequado; ou não serem devidamente registados, reportados e sujeitos a controlo e fiscalização. Exemplos incluem libertações de fundos tardias ou incompletas, recursos não rastreáveis até às unidades sanitárias, fragilidades no controlo da folha salarial, contratação e gestão de medicamentos e equipamento, inventários e activos, financiamento externo fragmentado ou fora dos sistemas nacionais, deficiências de contabilidade e de reporte, e seguimento insuficiente das constatações de auditoria.

¹ PEFA Secretariat (2016). Framework for Assessing Public Financial Management.

² International Monetary Fund (2013). Public Financial Management and Its Emerging Architecture. Washington, DC: IMF.

³ World Bank & World Health Organization (2026). FinHealth Toolkit 2.0: Public Financial Management in the Health Diagnostic Toolkit.

⁴ World Health Organization & World Bank (2025). Budget Execution in Health: From Bottlenecks to Solutions.

⁵ PEFA Secretariat (2023). Guidance on How to Use PEFA for Fiduciary Assurance.

Distinção importante. Fragilidade na GFP e risco fiduciário não são sinónimos. A GFP descreve o sistema e o seu desempenho; a análise do risco fiduciário considera a probabilidade e as consequências dos recursos não serem utilizados com economia e eficiência para os fins previstos. Uma fragilidade na GFP pode aumentar o risco fiduciário, mas a avaliação do risco exige considerar a natureza da exposição, os controlos existentes e as consequências potenciais.

3. Espaço Fiscal (EF)

Definição geral. Espaço fiscal é a margem para adoptar política fiscal discricionária relativamente aos planos existentes sem comprometer a sustentabilidade fiscal. Na formulação operacional do FMI, há espaço fiscal quando o governo pode aumentar a despesa ou reduzir impostos sem comprometer o acesso ao financiamento nem a sustentabilidade da dívida. A sua avaliação é prospectiva e multidimensional, considerando, entre outros factores, a posição macroeconómica, o nível e a trajetória da dívida pública, as necessidades de financiamento presentes e futuras, as condições de financiamento, os riscos fiscais e a capacidade de absorver choques. Por isso, espaço fiscal não é simplesmente saldo orçamental não utilizado, receita adicional ou capacidade de endividamento.^{6 7}

Aplicação ao Sector da Saúde. O espaço fiscal para a saúde é a margem para aumentar ou sustentar recursos públicos para a saúde, sem comprometer a sustentabilidade fiscal nem deslocar de forma inadequada outras despesas públicas prioritárias. A literatura da OMS e do Banco Mundial identifica como vias relevantes: crescimento económico e expansão da receita pública geral; maior prioridade à saúde no orçamento; receitas específicas ou consignadas, quando apropriadas; recursos externos; e ganhos de eficiência. A análise deve ser integrada no contexto macrofiscal e no processo orçamental do país, e não tratada apenas como procura de novas receitas para o Sector da Saúde.⁸

Duas qualificações são essenciais: a mobilização de recursos domésticos é uma possível fonte de expansão do espaço fiscal, mas não é sinónimo de espaço fiscal; e uma dotação orçamental maior não se traduz automaticamente em espaço fiscal efectivo para a prestação de serviços. A OMS destaca que libertações tardias, incompletas ou desalinhadas, e outros problemas de GFP podem reduzir o envelope efectivamente disponível para a saúde; inversamente, uma GFP mais previsível e flexível pode permitir uma melhor utilização do orçamento existente.⁹

Relação entre os três conceitos. Os três conceitos respondem a perguntas diferentes, mas complementares. O espaço fiscal pergunta que margem sustentável existe, ou pode ser criada, para decisões de despesa pública. A GFP pergunta como os recursos públicos são planeados, afectados, executados, controlados, contabilizados, reportados e fiscalizados. O risco fiduciário pergunta que grau de risco existe de os recursos não serem utilizados com economia e eficiência para os fins previstos. No Sector da Saúde, criar espaço fiscal é insuficiente se o orçamento não for credível ou executável; e melhorar a execução não elimina, por si só, riscos fiduciários. Uma abordagem completa deve, portanto, considerar conjuntamente sustentabilidade fiscal, qualidade da GFP, risco fiduciário e capacidade de transformar recursos em serviços e resultados de saúde.

⁶ International Monetary Fund (2016). Assessing Fiscal Space: An Initial Consistent Set of Considerations. IMF Policy Paper.

⁷ International Monetary Fund (2018). Assessing Fiscal Space: An Update and Stocktaking. IMF Policy Paper.

⁸ World Health Organization. Fiscal Space for Health. Health Financing and Economics.

⁹ Barroy, H. et al. (2016). Assessing fiscal space for health expansion in low- and middle-income countries: a review of the evidence. WHO Health Financing Working Paper No. 3.